Клинические рекомендации

Доброкачественные остео- и хондрогенные опухоли носа и пазух

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D14.0** — Среднего уха, полости носа и придаточных пазух
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 04.03.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/756_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определения 2

2.2 Этиология 2

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 3

3. Диагностика 3

3.1 Жалобы и анамнез 3

3.2 Осмотр 3

3.3 Передняя риноскопия и видеориноскопия 4

3.4 Компьютерная томография носа и околоносовых пазух 4

3.5 Биопсия 4

4. Лечение 4

4.1 Остеома 4

4.2 Другие опухоли 5

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 5

5.1 Показания к госпитализации 5

5.2 Реабилитация и наблюдение 5

6. Источник и актуальность 6

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 6

1. Основные положения

- Остеома, остеобластома, фиброзная дисплазия, аневризматическая костная киста, оссифицирующая фиброма, гигантоклеточная опухоль, хондрома и другие костные и хрящевые опухоли носа и околоносовых пазух. Чаще всего — остеома лобной пазухи.
- Стойкий или прогрессирующий на фоне лечения односторонний воспалительный процесс в носу и пазухах — всегда повод исключить опухоль: КТ носа и пазух, при необходимости биопсия.
- Диагноз — по жалобам, анамнезу, осмотру, эндоскопии полости носа и КТ носа и околоносовых пазух.
- Лечение хирургическое. При небольшой бессимптомной остеоме — наблюдение; после операции — КТ через **3–6 месяцев**, затем через год и более.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Опухоли

Опухоль	Определение
Остеома	медленно растущая (0,44–6,0 мм в год) опухоль из костной ткани; случаев малигнизации не описано
Остеобластома	редкая опухоль из костной ткани, продуцирующая ретикуло-фиброзные перекладины, окружённые крупными остеобластами
Фиброзная дисплазия	опухолевидное поражение: разрушение костной ткани с деформацией и заполнением костномозгового канала фиброзной тканью
Аневризматическая костная киста	редкое заболевание кости с локальным деструктивным и экспансивным ростом
Оссифицирующая фиброма	опухоль из кальцификатов, цемента, костной и фиброзной ткани; ювенильная форма течёт агрессивнее
Гигантоклеточная опухоль (остеокластома)	редкое новообразование кости с локально-агрессивным, деструктивным ростом
Хондрома	истинная опухоль из хрящевой ткани, развивается от 3 месяцев до 10 лет
Хондромиксоидная фиброма	редкая опухоль из веретеновидных или звёздчатых клеток в миксоидной или хондроидной строме
Хондробластома	редкая опухоль из хондробластов
Носовая хондромезенхимальная гамартома	опухоль из веретенообразных клеток, хрящевой ткани и геморрагических кист

2.2 Этиология

Причины окончательно не установлены. Возможные факторы риска — нарушение эмбриогенеза, инфекция, травма; при фиброзной дисплазии основную роль играет мутация гена GNAS1.

2.3 Классификация

Общепринятой классификации нет; классификации отдельных опухолей рабочие и учитываются при планировании лечения.

Рабочие классификации

1. остеома по строению: компактная, губчатая, смешанная;
2. остеобластома по скорости роста: латентная, активная, агрессивная;
3. фиброзная дисплазия: монооссальная (70–85%) и полиоссальная (15–30%);
4. аневризматическая костная киста, фазы: остеолиз, отграничение, восстановление;
5. хондрома: энхондрома (внутри кости) и экхондрома (на поверхности кости).

2.4 Клиническая картина

Жалобы появляются с ростом опухоли — при давлении на стенки пазух и распространении на соседние области; небольшие опухоли бессимптомны и бывают случайной находкой при КТ.

Частые жалобы

1. головная боль в носо-лицевой области, в проекции пазухи;
2. заложенность носа, аносмия — при обтурации соустья, вторичном синусите, мукоцеле;
3. рецидивирующие носовые кровотечения — при аневризматической костной кисте;
4. асимметрия и безболезненный отёк лица — при фиброзной дисплазии.

Распространение на орбиту и в полость черепа

1. деформация носоглазничной области, проптоз, периорбитальная боль, хемоз, диплопия;
2. слезотечение — при сдавлении носослёзного канала;
3. снижение зрения — при сдавлении зрительного нерва;
4. общемозговые и очаговые симптомы, менингит, абсцесс мозга — при интракраниальном распространении.

---

3. Диагностика

Диагноз — по жалобам, анамнезу, физикальным данным, эндоскопической ревизии полости носа и носоглотки и КТ носа и околоносовых пазух. Симптомы неспецифичны и в начале минимальны; остеома бессимптомна в 4–10% случаев и случайно выявляется при КТ у 1–3% обследованных.

3.1 Жалобы и анамнез

Уточняют

1. сроки, последовательность и динамику жалоб;
2. прежние травмы и заболевания носа и пазух, их лечение и эффект;
3. результаты прежних обследований: анализы, КТ, МРТ, биопсия, протоколы операций;
4. похожие жалобы у близких родственников.

3.2 Осмотр

Общий осмотр, пальпация и перкуссия носо-лицевой области, пальпация подчелюстных, подподбородочных и глубоких шейных лимфоузлов. Для доброкачественных опухолей изменения регионарных лимфоузлов не характерны.

3.3 Передняя риноскопия и видеориноскопия

Всем — передняя риноскопия: преддверие, передние отделы полости носа, раковины, перегородка, отделяемое; новообразование в передних отделах.

Всем — видеориноскопия риноскопом или фиброскопом; первичный осмотр — без подготовки и анестезии.

3.4 Компьютерная томография носа и околоносовых пазух

При подозрении на опухоль — КТ от твёрдого нёба до верхней границы лобной пазухи, срез **2 мм**: локализация, распространённость, размеры, структура, кальцификация, ремоделирование кости.

Остеома на КТ

1. компактная: округлое плотное почти бесструктурное образование;
2. губчатая: грубо-трабекулярная структура;
3. смешанная: зона 300–600 ед. Н губчатого строения и зона более 800 ед. Н компактного вещества.

Фиброзная дисплазия на КТ — однородная ткань «матового стекла» плотностью около 300–450 ед. Н, не инкапсулирована; кистозная форма — с участками более низкой плотности.

Остеобластома на КТ — сочетание плотной кости и участков затемнения.

Хондрома на КТ — образование гетерогенной плотности с чёткими границами и очагами минерализации.

Остеохондрома на КТ — костное вещество неоднородной плотности в центре, ткань хрящевой плотности по периферии.

МРТ и консультации челюстно-лицевого хирурга, офтальмолога, нейрохирурга — обязательно при

1. изменениях зубочелюстной системы: смещение, расшатывание, выпадение зубов, деформация;
2. глазных симптомах: проптоз, периорбитальная боль, хемоз, диплопия, слезотечение;
3. менингеальных и очаговых неврологических симптомах.

3.5 Биопсия

По показаниям — биопсия и патологоанатомическое исследование с иммуногистохимией: отличить доброкачественную опухоль от злокачественной. Обычно прицельная биопсия под эндоскопом на границе опухоли со здоровой тканью; при небольшой опухоли — эксцизионная.

---

4. Лечение

Хирургическое лечение эндоназальным, наружным или комбинированным доступом; при большой распространённости — транспалатинный доступ, боковая ринотомия, краниофациальная резекция, midfacial degloving. Навигация повышает эффективность и безопасность.

4.1 Остеома

Эндоназальный (эндоскопический), наружный или комбинированный доступ — по размерам и месту прикрепления. Наружный доступ травматичнее: эстетический дефект, парестезии, прозопалгия.

Небольшая бессимптомная остеома — выжидательная тактика; по некоторым данным, оперируют остеому, занимающую **более 50%** объёма пазухи. Рецидивы редки, через **5–8 лет**.

Классификация остеом лобной пазухи по A. G. Chiu, 2005

Степень	Остеома лобной пазухи
1	прикреплена сзади-снизу, медиальнее плоскости бумажной пластинки; переднезадний размер меньше 75% лобного кармана

Степень	Остеома лобной пазухи
2	то же расположение, переднезадний размер больше 75% лобного кармана
3	прикреплена спереди или сверху и (или) выходит латеральнее плоскости бумажной пластинки
4	полностью обтурирует лобную пазуху

Эндоскопическое удаление

1. предпочтительно при остеомах 1 и 2 степени, описано и успешное удаление 3 и 4 степени;
2. не показано при остеоме на передней и нижней стенке латеральных отделов лобной пазухи;
3. интраорбитальное и интракраниальное распространение — не абсолютное противопоказание.

4.2 Другие опухоли

Лечение по виду опухоли

Опухоль	Лечение
Остеобластома	хирургическое удаление; радикальное — обычно полное излечение, без рецидивов 5–15 лет; у детей рецидивы до 32%
Фиброзная дисплазия	выжидательная тактика с наблюдением и КТ — возможен регресс; операция — при выраженной деформации и ограниченном процессе; бифосфонаты — профилактика переломов и боли (риск остеонекроза челюсти)
Аневризматическая костная киста	хирургическое удаление: от пункции до кюретажа и резекции; до операции — эмболизация питающих сосудов; рецидивы 10–30%
Оссифицирующая фиброма	раннее и полное удаление; ювенильная форма рецидивирует до 30%, риск сохраняется до 18 лет — длительное наблюдение
Гигантоклеточная опухоль	хирургическое удаление; длительное наблюдение; если радикальная операция невозможна — лучевая терапия
Хондрома	хирургическое удаление (риск малигнизации): эндоскопически, при распространении в пазуху и орбиту — по Денкеру
Хондромиксоидная фиброма	хирургически: кюретаж эффективен в 80%; предпочтительна широкая эксцизия
Хондробластома	радикальное иссечение; после одного кюретажа рецидивы до 55%

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Госпитализация

1. доброкачественная остео- или хондрогенная опухоль носа и пазух без противопоказаний к плановой операции.

Выписка

1. нет осложнений, удовлетворительное общее состояние.

5.2 Реабилитация и наблюдение

После удаления опухоли — охранительный режим **10–14 дней и более**.

Специфической профилактики нет. После операции — динамическое наблюдение: КТ **через 3–6 месяцев**, затем **через 1 год и более** — по виду опухоли, локализации и радикальности операции.

Прогноз зависит от гистологии, локализации и распространённости. Радикальное удаление обычно излечивает, но из-за рецидивов и возможной малигнизации нужно наблюдение.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Доброкачественные остеогенные и хондрогенные опухоли носа и околоносовых пазух»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 04.03.2023
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее марта 2026 года
Код в рубрикаторе	756_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В критериях оценки качества уровни доказательности (КТ — УУР А, УДД 1; операция — А, 4; охранительный режим — В, 2) не совпадают с уровнями этих рекомендаций в тексте (С, 4–5).